

Kooperationsszenarien
Hausarzt - Dr Ingo Sulin

Diabetespatient wird zum Frakturausschluss an Orthopädie verwiesen

Kooperationspartner: Diabetologische Schwerpunktpraxis, Orthopädisches Zentrum / Radiologie

Kooperationsbeschreibung: Die Kooperation dient der präventiven und interdisziplinären Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms (DFS) mit Fokus auf die diabetische Neuro-Osteoarthropathie (DNOAP). Ziel dieser Behandlung ist die frühzeitige Erkennung von Frakturen bei fehlendem Schmerzempfinden und die Abstimmung von systemischen und lokalen Therapien. Durch standardisierte Kommunikationswege (FHIR) wird die Behandlungsqualität gesteigert und das Risiko schwerer Komplikationen, besonders Amputationen, stark gesenkt. Die Kooperation umfasst einen priorisierten Zugang zur Bildgebung und einen beschleunigten digitalen Datenaustausch.

Fälle: Älterer Diabetiker (Typ 2), Polyneuropathie, schmerzlose Weichteilschwellung am Fuß, Verdacht auf Charcot-Fuß.

Daten:

Diabetologie an Orthopädie: Stammdaten, Diagnose (ICD E11.9), klinischer Kontext (Schmerzlosigkeit, Verdacht DNOAP), Auftrag zur Bildgebung (ServiceRequest).

Orthopädie an Diabetologie: Radiologischer Befund (DiagnosticReport), Beurteilung der Knochenstruktur (Frakturausschluss), Link zu den Röntgenbildern.

Behandlungskontext:

Diabetologie: Ersteinschätzung der Schwellung, Optimierung der Blutzuckereinstellung, Verordnung von Druckentlastung (z.B. Verbandschuh) bis zum Befund.

Orthopädie: Durchführung der Röntgen-Diagnostik in 2 Ebenen, Beurteilung von Mikrofrakturen und Gelenkfehlstellungen, Ausschluss osteolytischer Prozesse.

Prozess:

Ersterkennung und Triage: Der Hausarzt identifiziert bei der Fußkontrolle eine schmerzlose, warme Schwellung ("Roter Fuß") und initiiert einen beschleunigten Überweisungsprozess zum Röntgen.

Spezialdiagnostik: Der Orthopäde/Radiologe übernimmt die Bildgebung. Dank der übermittelten Kontext-Daten ("Diabetes") achtet er spezifisch auf Anzeichen einer DNOAP.

Konsil: Innerhalb kürzester Zeit erfolgt der digitale Rücklauf des Befundes an den Hausarzt, um eine sofortige Belastungsentscheidung zu treffen.

Therapieanpassung: Der Hausarzt passt basierend auf dem Frakturausschluss die

Entlastungsstrategie an (z.B. Total Contact Cast).

Regelmäßiger Austausch: Verlaufskontrollen der Schwellung und ggf. Folgeröntgen werden elektronisch zwischen den Praxen koordiniert.